

당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다

당뇨병 첫 외래 안내 — 진단의 의미부터 오늘 하는 검사, 우리가 함께 할 일까지

진단 직후가 가장 중요합니다 — 지금 시작하면 평생이 달라집니다

당화혈색소(HbA1c, 지난 2~3개월 평균 혈당)를 1%만 낮춰도 눈·신장·신경 합병증이 크게 줄어듭니다 — 첫 1~2년 관리가 평생을 좌우

37%

오늘의 메시지

당뇨병은 그 자체보다 합병증이 두려운 병입니다. 그러나 합병증은 **예방 가능합니다**. 진단은 끝이 아니라 관리의 시작점이며, 가장 효과가 큰 시점이 바로 지금입니다. 약·식사·운동·검사 네 가지를 함께 맞춰가면 합병증 없이 평생 지낼 수 있습니다.

HbA1c 1% 감소 시 미세혈관 합병증(눈·신장·신경) 위험 감소
— 진단 초기의 좋은 조절은 시간이 지나도 효과가 남는다는 연구 결과가 있습니다.

당뇨병 진단이 의미하는 것

혈당을 낮추는 인슐린이 잘 듣지 않고(저항성), 만드는 양도 줄어든 상태 — 둘 다 관리할 수 있습니다



혈당이 만성적으로 높아진 상태 — 핵심은 인슐린 저항성과 인슐린 분비 감소가 함께 일어난다는 점입니다.

내장지방이 늘면 간·근육·지방이 인슐린에 둔감해집니다(저항성). 췌장은 이를 메우려 인슐린을 더 짜내다 점차 지칩니다. 그래서 당뇨병은 "의지가 약해서" 생기는 병이 아니라 **체질·유전·생활이 겹친 대사질환**입니다. 다행히 두 기전 모두 약과 생활습관으로 되돌리거나 늦출 수 있습니다.

인슐린 저항성

간·근육·지방

체중 감소·운동으로 가장 잘 개선되는 부분입니다.

베타세포 기능

진단 시 ≈ 50%

조기에 부담을 덜어주면 남은 기능을 오래 지킬 수 있습니다.

오늘 첫 외래에서 하는 검사 — 출발점을 확인합니다

지금의 혈당 수준과 이미 시작된 합병증이 있는지 한 번에 점검합니다 (일부는 채혈·예약으로 진행)

검사 · 01

혈당 · 당화혈색소(HbA1c)



공복혈당 + 최근 2~3개월 평균인 HbA1c로 현재 조절 수준과 첫 목표치를 정합니다.

검사 · 02

혈압 · 지질(콜레스테롤)



당뇨는 혈관병입니다. 혈압·나쁜 콜레스테롤(LDL)을 함께 관리해야 심근경색·뇌졸중을 막습니다.

검사 · 03

신장 — 소변알부민 · eGFR



콩팥 합병증은 초기에 증상이 없습니다. 소변검사(uACR, 소변 속 단백)와 혈액검사(eGFR, 콩팥 거르는 기능)로 가장 먼저 신호를 잡습니다.

검사 · 04

눈(안저) · 발 검진



진단 시 안저검사 1회 + 발 감각·맥박 확인. 망막·신경 합병증 조기 발견용입니다.

함께 관리할 4가지 축 — 혼자 하지 않습니다

네 가지가 서로 맞물려야 혈당이 안정됩니다. 한 번에 다 바꾸지 않고 하나씩 같이 만들어갑니다

PILLAR · 01

식사 — 점시법



1/2 채소, 1/4 단백질, 1/4 통곡물. 굵지 않고 균형을 맞추는 것이 핵심입니다.

PILLAR · 02

운동 — 주 150분



빠르게 걷기 등 중강도 유산소 + 주 2회 근력. 식후 10분 걷기부터 시작합니다.

PILLAR · 03

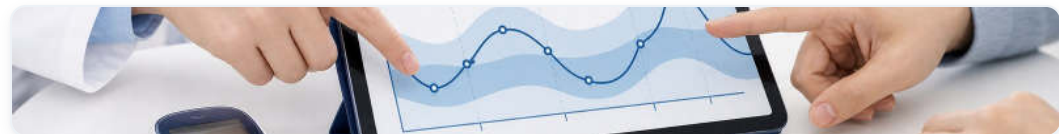
약물 — 부담 없이 시작



대부분 메트포민으로 시작합니다. 동반질환이 있으면 장기 보호 약도 함께 정합니다.

PILLAR · 04

자가측정 — 내 패턴 알기



음식·운동·약의 효과를 기록으로 확인합니다. 다음 진료 때 흐름을 함께 봅니다.

약물의 시작 — 메트포민, 걱정보다 안전합니다

40년 이상 검증된 1차 약. 저혈당·체중 증가가 거의 없고, 서서히 늘려 부작용을 줄입니다

 **메트포민(Metformin)은 간에서 당이 과하게 만들어지는 것을 줄이고 인슐린 감수성을 높이는 모든 환자의 1차 약물입니다.**

500mg 1회로 시작해 1~2주마다 천천히 늘립니다. 속이 불편할 수 있어 **식사와 함께** 복용하고 서서히 증량하면 대부분 적응합니다. 임의로 끊지 말고, 속쓰림·설사가 심하면 줄이거나 천천히 녹는 형태(서방형)로 바꿀 수 있으니 알려주세요. 콩팥 기능이 많이 떨어졌거나(eGFR 30 미만) 조영제 검사 전후에는 잠시 중단합니다.

HbA1C 감소

1.0 ~ 1.5 %

체중 중립 · 저혈당 거의 없음.

동반질환 시

심장·콩팥 보호약

심장·콩팥을 함께 보호하는 비교적 새로운 당뇨약(SGLT2 억제제·GLP-1 계열)을 처음부터 같이 쓰기도 합니다.

식사 — 무엇을 더하고 무엇을 줄일까

완벽한 식단이 아니라 매 끼의 작은 선택이 쌓입니다 — 진단 직후부터 시작하면 가장 효과적

+ 🍴 늘리기 — 혈당을 안정시키는 선택

- + 접시법 — ½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물
- + 채소 먼저 먹기 — 식후 혈당 상승 완화
- + 식이섬유 25g/일 — 채소·통곡물·콩
- + 물·무가당 음료로 갈증 해결
- + 일정한 식사 시간 — 거르지 않기
- + 식후 10분 걷기 — 가장 쉬운 혈당 관리

— 🍷 줄이기 — 혈당을 급등시키는 선택

- 정제 탄수화물 — 흰밥·흰빵·국수 과다
- 가당 음료·주스 — 콜라·믹스커피
- 야식·폭식 — 식후 혈당 급등
- 국물·젓갈 과다 — 혈압까지 악화
- 과음 — 저혈당·간 부담
- 과일주스·말린 과일 — 농축된 당 주의

나의 첫 목표치 — 숫자로 함께 확인합니다

목표는 사람마다 다릅니다. 나이·동반질환·저혈당 위험을 고려해 함께 조정합니다 (일반 성인 기준)

TARGET · 01

당화혈색소 HbA1c — 대부분 6.5% 이하



나이가 많거나 저혈당 위험이 크면 7~8%로 함께 조정합니다. 내 목표치는 진료 때 정합니다.

TARGET · 02

공복혈당 80 ~ 130 · 식후 < 180



매 끼니가 아니라 평균과 패턴이 중요합니다. 자가측정으로 흐름을 봅니다.

TARGET · 03

혈압 < 130/80 mmHg



당뇨 환자는 대부분 130/80 미만이 목표입니다(위험인자 없으면 다소 완화). 가정혈압을 같은 시간에 재 보세요.

TARGET · 04

LDL 콜레스테롤 < 100 (고위험 < 70)



혈관 보호를 위해 스타틴을 함께 쓰는 경우가 많습니다. 목표는 위험도에 따라 정합니다.

앞으로의 일정 — 함께 가는 길

오늘이 끝이 아닙니다. 아래 흐름으로 함께 점검하며 약과 목표치를 맞춰갑니다 (개인별로 조정)

STEP · 01 · 오늘

첫 평가 · 약 시작



기본 검사로 출발점 확인 + 메트포민 시작 + 자가측정 방법 안내. 궁금증은 무엇이든 물어보세요.

STEP · 02 · 1~2주 후

약 적응 · 증량 점검



속이 불편하지 않은지 확인하고 필요하면 용량을 올립니다. 자가측정 기록을 함께 봅니다.

STEP · 03 · 약 3개월 후

HbA1c 재검 · 목표 확인



첫 목표 달성 여부를 확인하고 약·생활을 조정합니다. 안정되면 6개월 간격으로 늘립니다.

STEP · 04 · 이후 정기

합병증 정기 검진



연 1회 안저·신장(소변·혈액)·발 검진으로 합병증을 조기에 잡습니다. 예방접종도 함께 챙깁니다.

이럴 땐 바로 연락 또는 내원하세요

초기에는 드물지만, 아래 신호는 급성 합병증의 경고입니다 — 망설이지 말고 알려주세요

URGENT · 01

저혈당 (혈당 < 70)



식은땀·떨림·어지러움이 오면 바로 당분 섭취 — 주스 반 컵·사탕 3~4개·설탕 1큰술(약 15g). 15분 뒤 다시 측정. 의식이 흐리면 먹이지 말고 119.

URGENT · 02

심한 고혈당 · 의식 변화



구토·복통·가쁜 숨·의식 변화가 있으면 혈당과 관계없이 즉시 응급실. 증상 없이 혈당만 높게(300 이상) 지속돼도 빨리 연락하세요.

WATCH · 03

갑작스러운 시력 변화



물체가 일그러지거나 검은 점·시야 가림 — 눈 속 출혈이 의심되니 빠른 안과 평가가 필요합니다.

WATCH · 04

발 상처가 안 나옴



상처가 2주 이상 지속되거나 붓고 열나고 냄새 — 당뇨발 진행, 빨리 보여 주세요.

WATCH · 05

가슴 답답함 · 호흡곤란



활동 시 가슴 압박감·식은땀 — 당뇨는 무증상 심근경색이 흔해 늦지 않게 평가합니다.

WATCH · 06

부종 · 거품뇨 · 소변량 감소



다리 부종·거품뇨 — 콩팥 합병증 신호. uACR·eGFR를 다시 확인합니다.

첫 외래 후 실천 7가지

오늘 집에 가서 시작할 일입니다. 완벽하지 않아도 됩니다 — 꾸준함이 곧 치료입니다

01

약 매일 같은 시간 — 메트포민은 식사와 함께. 임의 중단 금지, 불편하면 알려주기.

02

혈당 자가측정 + 기록 — 공복·식후 2시간 번갈아, 진료 때 함께 검토.

03

접시법 + 식후 10분 걷기 — 가장 쉬운 두 가지부터 습관으로.

04

매일 발 살피기 — 상처·물집·색 변화 확인. 맨발·뜨거운 물 주의.

05

HbA1c 3개월 뒤 재검 — 첫 목표 달성 여부를 함께 확인하고 조정.

06

금연·절주 + 예방접종 — 합병증을 줄이는 가장 확실한 투자.

07

다음 예약 지키기 — 공금증·부작용은 메모해 오면 진료가 빨라집니다.

진단은 끝이 아니라 시작입니다 — 함께 가면 됩니다

궁금한 점은 언제든지 물어보세요. 첫 1~2년의 관리가 평생 합병증 위험을 결정합니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



다시 보기 · 카톡 공유